Ilustre Municipalidad
SAN CLEMENTE
Departamento
de Salud

GUÍA ANTICIPATORIA
de Lactancia Materna

Material elaborado por el Comité de Lactancia Materna



LACTANCIA MATERNA

La lactancia materna es la forma de alimentación que **contribuye con mayor efectividad al desarrollo físico y mental del niño**, proporcionándole nutrientes en calidad y cantidad adecuadas. **Se recomienda que el niño reciba leche materna en forma exclusiva durante los primeros seis meses de vida** y que constituya parte importante de la alimentación hasta los dos años.

La leche materna ha sido definida como un fluido bioactivo, que permite a los niños alimentados tener menor riesgo de contraer enfermedades infecciosas y presentar menor incidencia y severidad de éstas.

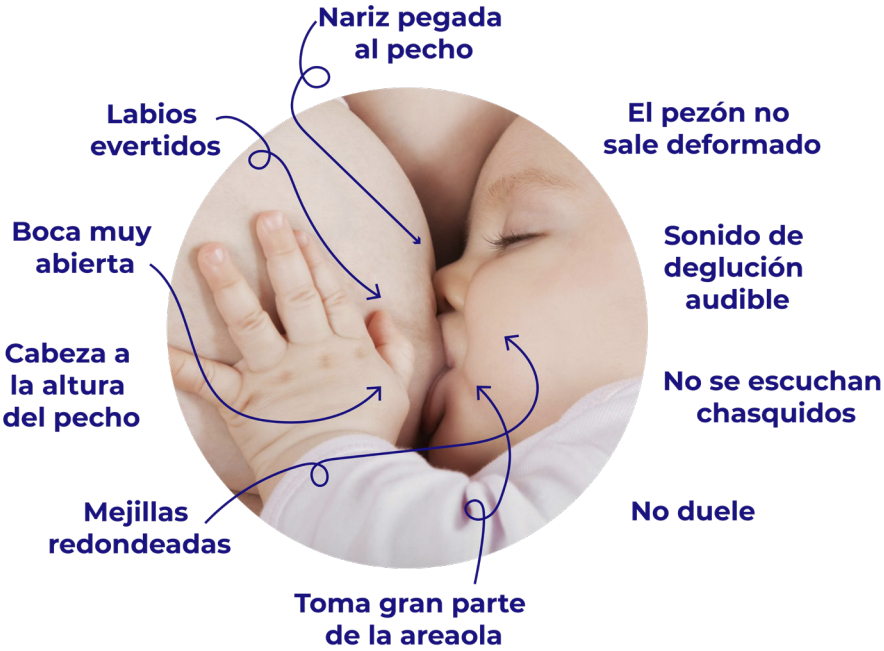
Recomendaciones internacionales

Las recomendaciones de la **OMS** y **UNICEF** establecidas en la Estrategia Mundial son:

- Lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida (180 días)
- Iniciar la alimentación complementaria a partir de los 6 meses de edad, manteniendo la lactancia materna hasta los dos años de edad o más.



TÉCNICA DE ACOPLE



Posiciones de amamantamiento

- Busque un lugar cómodo para amamanta
- Si va amamantar sentada busque un sillón donde tenga apoyo de espalda, brazos y pies.
- Use cojín de lactancia si así se siente más comoda, sobre todo si su bebe aún es pequeño.
- Debe acercar el bebe al pecho y no viceversa.
- No existe mejor o peor posición para amamantar, la más adecuada será aquella con la que usted se sienta más cómoda.
- Una adecuada posición permite un mejor acople, facilita una toma efectiva y alivia los malestares de cuello y espalda de la madre.

Posiciones para lactancia



POSICIÓN DE CUNA



POSICIÓN DE CUNA EN CRUZ



SOSTENIENDO COMO UN BALÓN



RECOSTADA



RECOSTADA DE LADO

PARTO VS CESÁREA

- Barrera para realizar apego piel a piel por al menos 1 hora.
- Impide a la madre vivir esta experiencia
- Estudio muestra que en promedio el apego piel a piel en madres con cesárea es de 11 a 15 minutos, es decir 45 minutos menos de lo recomendado.
- Lactancia se inicia a las 4 horas post parto aprox.
- Inicio tardío de lactancia y mayor incidencia de suplementación con fórmula.

- Amamantan menos veces durante el día Mayor perdida de peso del bebé.
- El dolor post cesárea interfiere negativamente con la lactancia.
- Hay 93% más de probabilidades de amamantar dentro de la primera hora por parto vaginal que por Cesárea.

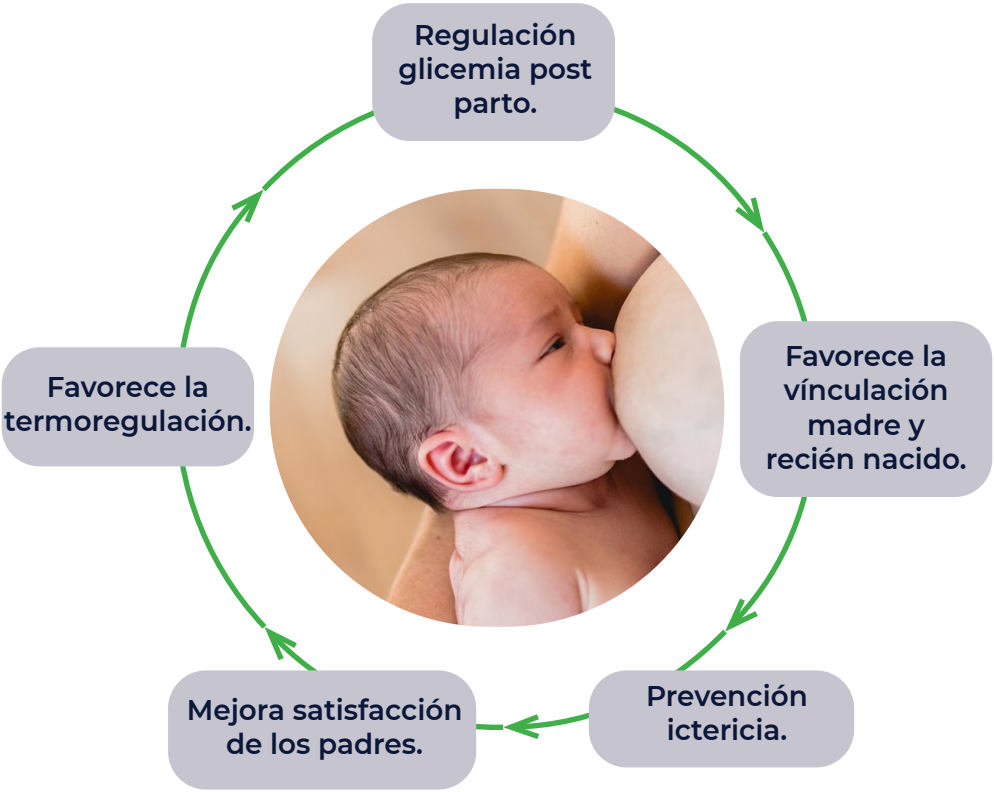


Contacto piel con piel, hora sagrada



- Mantener a la madre y su recién nacido juntos por al menos una hora después del parto es favorable para iniciar la lactancia materna y aumentar la duración de ésta. (OMS- MINSAL).
- El Recién nacido manifiesta un comportamiento instintivo que favorece y facilita la primera mamada.

La primera mamada



- El estrés del parto para el bebé se resuelve con el contacto piel con piel de su madre y con la primera mamada.
- La primera toma produce un peak de oxitocina en la madre, que contrae fuertemente el útero, previniendo hemorragias.

Capacidades gástricas

- El tamaño del estómago del bebe va aumentando con el paso de los días de nacido, como así también el volumen de producción de leche materna.
- Su cuerpo irá produciendo más leche a medida el bebe vaya succionando. Recuerde que a mayor succión mayor producción, confíe en su capacidad de producir leche.



El estómago del recién nacido



FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PRODUCCIÓN DE LECHE MATERNA

El estrés y preocupaciones, inhiben la actividad de las hormonas productoras de leche.

El dolor para amamantar, aumenta el estrés materno y disminuye la salida de la leche.

Apenas un 5% de las mujeres no puede producir leche materna, asociado a enfermedades previas o cirugías mamarias. Por lo tanto, la gran mayoría de las madres **SÍ PUEDE AMAMANTAR**, no dude de su capacidad de producir leche.

Señales de hambre del bebe

Es importante ofrecer el pecho al bebe apenas se detectan las primeras señales de hambre y no esperar a que este irritado y llorando.



Despierta tranquilo/a.

Abre la boca.





Busca el pecho.

Lleva sus manos a la boca.

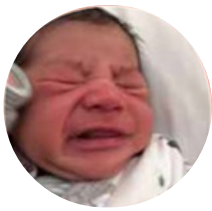




Comienza a enojarse.



Se encuentra irritado.



Llora.

Si ya es tarde y el bebe llora de hambre, primero se debe calmar y luego ofrecer el pecho. Con el paso de los días ira reconociendo de mejor forma las señales de hambre.

Señales que el bebe se esta alimentando correctamente



La lactancia materna es a libre demanda, sin horarios establecidos.
El primer mes debe dar de mamar a su bebe cada 2 horas aproximadamente durante el día y también por la noche, si no despierta, se aconseja cambiar el pañal, poner unas gotitas de agua tibia en la cara, quitar un poco de ropa, hasta que despierte y logre amamantarlo.

DIFICULTADES EN LA LACTANCIA MATERNA

Asociadas a la madre:

- **Grietas en el pezón**



Causadas habitualmente por mal acople. El mal acople puede ocurrir por uso de interferencias (chupetes, mamaderas) o mala técnica de amamantamiento

Manejo de grietas de pezón

Corregir acople es fundamental.

En heridas abiertas NO aplicar cremas, puede limpiar la herida utilizando suero.

En pezones irritados, puede aplicar unas gotitas de aceite de oliva para hidratar.

Deje secar los pechos al aire	**Puede usar de su propia leche luego de terminar de amamantar.**	**No suspenda la leche materna, puede originar otras complicaciones.**

Ingurgitación mamaria

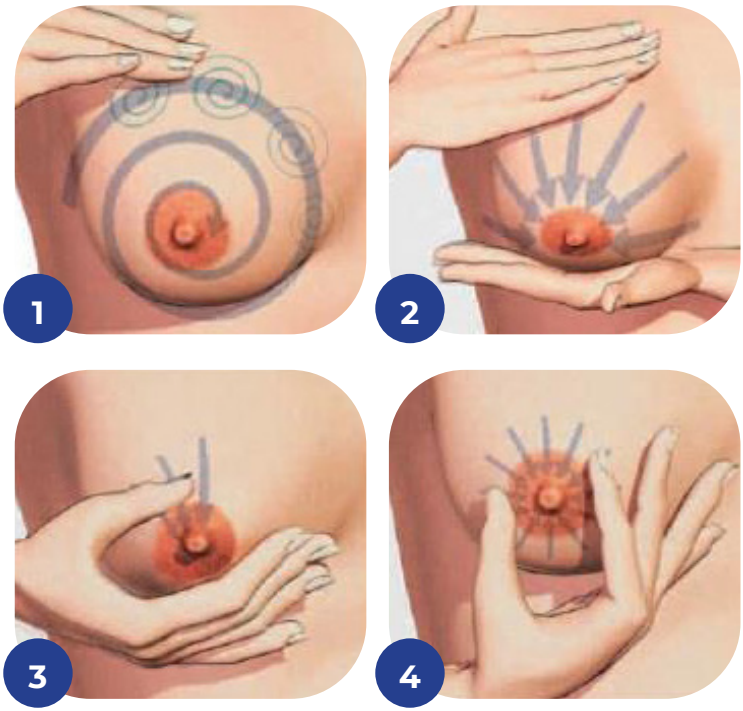


Se produce por el aumento de la vascularización de los pechos. Se suele generar después de partos prolongados en los que se han administrado líquidos endovenosos a la madre o por un mal inicio de la lactancia

Manejo de la ingurgitación

Aplicar frío en el pecho, evitando el pezón y la areola.	**Evita aplicar calor en el pecho.**	**Realiza los masajes de presión inversa suavemente antes de amamantar o antes usar el extractor de leche.**
Puede colocar hojas de repollo frias envolviendo las mamas para aliviar el malestar.	**Realice masajes en sus pechos antes de amamantar.**	**No suspenda la leche materna, puede originar otras complicaciones.**

Masajes para realizar antes de amamantar



Congestión Mamaria



Puede ser provocada por: Inicio tardio de la lactancia, mamadas infrecuentes, mamadas limitadas en el tiempo, reemplazo de mamadas por fórmulas lácteas sin extracción de leche.

Manejo de la Congestión mamaria

Amamantamiento frecuente y efectivo.

Si el bebe no logra vaciar el pecho, extraer leche de forma manual o con extractor para disminuir las molestias.

Descongestionar la areola.

Masaje areolar y pecho.

Antes y después del amamantamiento; aplicar compresas frías.

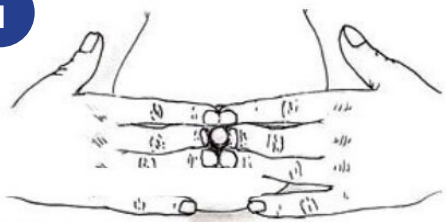
Vaciamiento frecuente de 1 pecho en cada toma y alternar en la siguiente.

Optimizar acople profundo del pecho.

No suspenda la lactancia.

Masajes para descongestionar areola

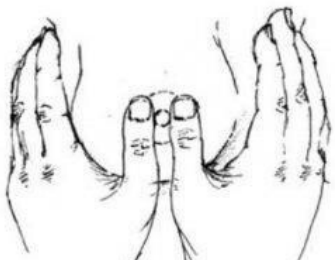
1



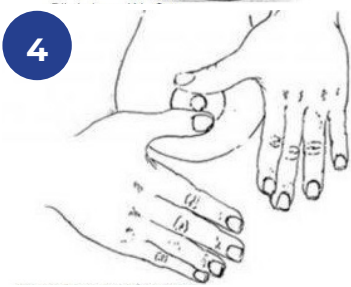
2



3

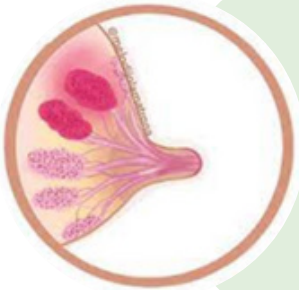


4



Dibujado por Kyle Cotteman

Obstrucción de conductos



Mucho dolor, calor y posible enrojecimiento de una zona del pecho. Se puede sentir una masa palpable bien definida, sin fiebre. En ocasiones se puede visualizar una **“perla de leche”** en la punta del pezón.

Manejo de la obstrucción de conductos

Optimizar acople.

Amamantar en forma frecuente.

Comenzar con el pecho afectado.

Aplicar calor húmedo antes de amamantar.

Masajear el pecho antes y durante el amamantamiento.

Alternar posiciones de amamantamiento para facilitar el vaciamiento de distintas zonas del pecho.

No suspenda la lactancia.

Para evitar obstrucciones debe revisar constantemente sus pechos, buscando zonas más duras, Realice masajes circulares con las yemas de sus dedos desde la axila hasta la punta del pezón, sin presionar, suaves, lo que va facilitar la bajada de la leche retenida.

Perlas de leche



Existen dos tipos distintos de perlas de leche.
Producidas por causas traumáticas: Tirón, mordedura, se observa un punto blanco superficial en el pezón, se pueden drenar y cesa el dolor. Producidas por causas infecciosas, son mas profundas, no se pueden drenar, dolor profundo al amamantar, producidas generalmente por obstrucciones en los conductos del pezón.

Manejo de las perlas de leche

Masajes circulares desde la axila hasta la punta del pezón.

Poner calor local o duchas calientes previo a cada toma, para disminuir el dolor.

Debe continuar amamantando o extraerse la leche, aunque duela.

Su leche no está infectada.

Tienen una duración de 7 a 10 días aprox, luego desaparecen.

Si son producidas por una obstrucción y esta no se resuelve la perla de leche continurá.

No pinche las perlas de leche en su casa, puede complicar aun más el cuadro provocando una infección.
Es importante identificar la causa de la perla de leche para su manejo, si fue provocada por un tirón o mordedura en un par de días se tornará amarilla y se caerá, pero si es provocada por una obstrucción y esta no se resuelve puede durar muchas semanas, pudiendo evolucionar a mastitis.

DIFICULTADES EN LA LACTANCIA MATERNA

Asociadas al niño:

- **Frenillo sublingual corto**



Definido como una banda de tejido fibroso recubierta por mucosa, que une la base de la lengua en su línea media y se proyecta al piso de la boca, el frenillo sublingual corto (también llamado anquiloglosia) puede ocasionar dolor al amamantar, succión ineficiente de leche, bajo incremento de peso.

Manejo de frenillo sublingual corto

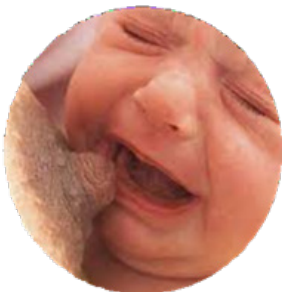
Dependiendo de su intensidad debe ser evaluado por odontopeditra para su corte

Esta es una cirugia ambulatoria de muy rapida recuperación (Frenectomia).

Luego del corte del frenillo, el dolor cesa inmediatamente y la transferencia de leche es eficaz.

Crisis de lactancia

Son etapas del desarrollo del bebé más o menos estables, en donde cambia el patrón de alimentación , por lo que se ponen más demandantes en sus tomas o parecen no estar satisfechos con su lactancia.



15-20 días

- **En esta etapa se produce un brote de crecimiento, el bebé no suelta la teta y si lo hace vuelve a pedir muy rápido, no quiere dormir y usted puede incluso sentir sus pechos más blandos.**

- **¿Qué sucede?:** El bebé necesita aumentar la producción de leche y para eso necesita mamar más frecuente.
- **¿Qué hacer?:** Mucha paciencia, realice contacto piel con piel, evite mamaderas y chupetes.

6-7 semanas

- **El bebé lacta más y de manera más inquieta, llorando o tironeando el pezón, se arquea y tensa la espalda y piernas.**



- **¿Qué sucede?:** Esta dejando de producir leche de transición, ahora producirá leche madura, haciendo la leche un poco más salada.
- **¿Qué hacer?:** En pocos días el sabor de la leche se normaliza. Tenga paciencia.



3 meses

- **El bebé llora y pelea con el pecho, parece que no quiere mamar, se distrae con todo, tensa las piernas y espalda.**

- **¿Qué sucede?:** La lactancia ya está establecida, sus pechos comienzan a producir solo cuando el bebé succiona, puede demorar unos segundos en bajar la leche lo que impacienta al bebé. Ahora su hijo se distrae con más facilidad en las tomas.
- **¿Qué hacer?:** Tenga paciencia y trate de amamantar a su bebé en lugares tranquilos.

6 meses

- **El bebé a disminuido las tomas y cuando le ofrece se molesta, despierta más veces en la noche.**



- **¿Qué sucede?:** El bebé ya inició la alimentación complemenaria, por lo que disminuyen las tomas de día y aumentan las de la noche.
- **¿Qué hacer?:** Espere a que el bebé tenga más interés por mamae, ofrezca el pecho antes de la comida, nunca lo obligue a mamar.



1-2 años

- **El bebé a dejado de comer bien, quiere estar pegado a la teta, esta muy demandante como cuando estaba recién nacido.**

- **¿Qué sucede?:** A dejado de crecer tan rápido como lo hacía antes, entonces ya no necesita tanta comida, con la leche materna esta cubierto.
- **¿Qué hacer?:** Siga ofreciendo alimentos variados, no lo obligue a comer. Tenga paciencia cuando vuelva aumentar su velocidad de crecimiento volverá a comer.

Falsas crisis de lactancia



4 meses

- **¿Qué sucede?:** A esta edad los bebes incorporan fases de sueño que al nacer no tenían, esto produce que aumenten sus despertares nocturnos, ya que se mantiene mas tiempo en estado de sueño ligero.

- **¿Qué hacer?:** Tenga paciencia, este periodo puede durar algunos dias.

8 meses

- **¿Qué sucede?:** A esta edad se inicia la etapa llamada "angustia por separación", donde comienzan a entender que son un ser independiente de su madre, lo que les produce una gran angustia cuando pierden a su madre de vista, por las noches despiertan llorando y nerviosos, no quieren soltar el pecho.
- **¿Qué hacer?:** Paciencia, esta etapa puede resultar muy agotadora.

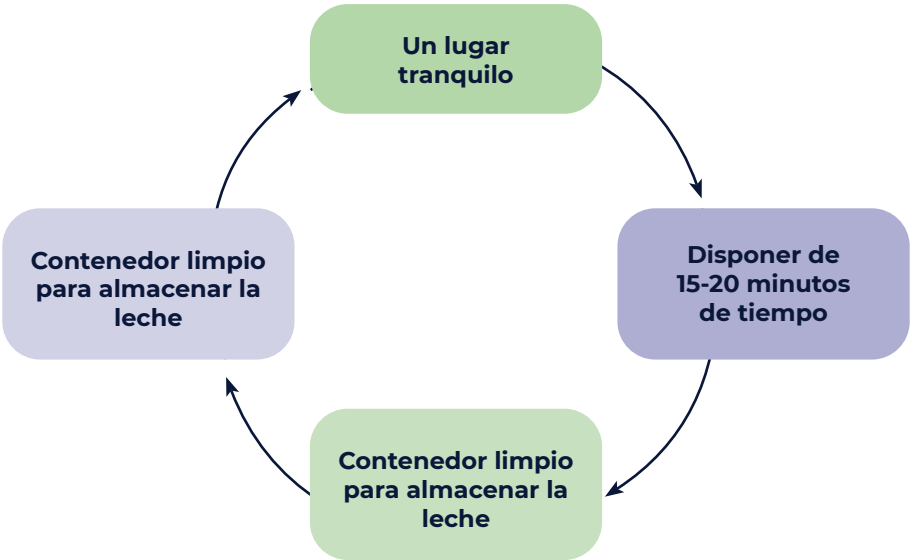
Huelgas de lactancia



- **¿Que sucede?:** Es un rechazo repentino al pecho, que se puede producir en cualquier etapa de la lactancia. Puede estar provocado por: Un cambio repentino en el estilo de vida del niño: mudanza, ingreso a sala cuna, Enfermedad: dolor, mocos Inicio de la dentición, miedo como cuando la madre grita despues que su hijo la mordió por ejemplo.
- **¿Qué hacer?:** Debe volver a enamorar a su hijo al pecho, no lo obligue a mamar y tenga presente que una huelga de lactancia NO ES DESTETE.
- **¿Qué hacer?:** Evitar distractores. Evaluar cambios de rutina. Descartar malestares. Cambiar de posición de amamantar. No obligar.
- Las huelgas de lactancia ocurren generalmente entre los 8 meses y el primer año.

Extracción de leche materna

¿Qué necesitas?



¿Cómo lo debe hacer?

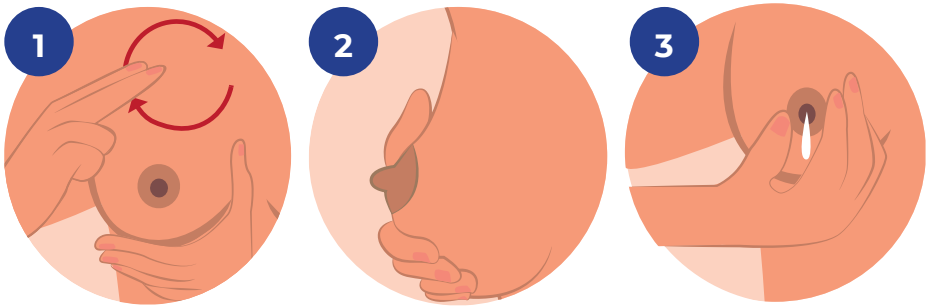


Lave bien sus manos con agua y jabon



Realice masaje en las mamaspara estimular la salida de la leche, puede aplicar un poco de calor para ablandar

Extracción manual



Paso 1
Para estimular la bajada de la leche, hazte masajes alrededor del pecho, en forma circular.

Paso 2
Coloca la mano en forma de “C”, aprieta sín deslizar los dedos y empuja suavemente contra las costillas.

Paso 3
Cuando salga la leche depositala en el recipiente.

Extracción con extractor



- Lo mas importante es el tamaño de la copa del extractor, ya que si no es la adecuada al tamaño de su pezón puede provocar grietas y no extraer la leche de forma correcta.

- Tenga presente que la leche qué se extrae no es la cantidad de leche qué usted produce, por lo tanto no se asuste si se extrae muy poca leche.

CONSERVACIÓN DE LECHE MATERNA

¿Cuánto dura la leche extraída?



A temperatura ambiente: 6 a 8 horas.



Cooler con unidades refrigerantes: 24 horas.



En el fondo del refrigerador: 5 días.



Freezer dentro del refrigerador: 2 semanas.



Freezer con puerta independiente 3 a 6 meses.



Freezer o congeladora independiente: 6 a 12 meses.

Almacenamiento



- Luego de extraída la leche, debe enfriarla rápidamente.
- Se pueden juntar Leches del mismo día, debe dejar las Leches en el refrigerador y cuando ambas estén a la misma temperatura se pueden guardar en el mismo envase.

- Debe rotular cada contenedor o bolsa, con la fecha de, hora y volumen de leche.
- Procure llenar el envase solo hasta 3/4 de su capacidad.
- Almacene en cada recipiente no más de 50 cc de leche, pues lo que su bebé no tome, no se puede volver a guardar.





- La leche materna debe ser almacenada en recipientes aptos para ello, que se ajusten a su presupuesto y espacio disponible para su almacenaje.
- Los envases más adecuados pueden ser de vidrio o plásticos libres de BPA, también existen bolsas de almacenaje con cierre hermético exclusivas para leche materna.

¿Cómo descongelar la leche materna?



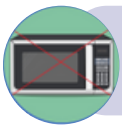
Debe sacar la leche del congelador el día anterior al refrigerador.



Bajo el chorro de agua caliente.



En falso baño maría.



Nunca en el microondas.

También debes saber:

La leche materna se separa en capas, en la parte superior se torna la grasa y en la parte inferior más transparente.

Agitar suavemente antes de dar al bebé

Debe eliminar la leche qué el bebé no se tomó luego de 1 a 2 horas.

Si su leche toma un sabor extraño luego de descongelarla y su hijo la rechaza, antes de congelarla debe calentarla hasta el inicio de la ebullición y luego llevarla al congelador (escaldar).

Guía anticipatoria de Lactancia Materna

Ilustre Municipalidad
SAN CLEMENTE
Departamento
de Salud

Ilustre Municipalidad
SAN CLEMENTE
Departamento
de Salud

NUESTRAS REDES SOCIALES

- Departamento Salud San Clemente
- Salud San Clemente Informa
- APS San Clemente
- APS San Clemente
- www.saludsanclementeinforma.cl
- "Prevenir es Salud" Radio Amiga 1020 AM
- Teléfonos OIRS: 712-621628
- Correo OIRS: oirs@saludsanclemente.cl

TeleSalud
Hacia una Atención Primaria Universal

SU HORA DE ATENCIÓN A UN CLIC

ESCANEE ESTE CÓDIGO QR

NÚMEROS DE TELEFÓNICOS DE UTILIDAD

AMBULANCIA **131**

BOMBEROS **132**

CARABINEROS **133**

CENTRAL DE EMERGENCIAS **1489** (Atención 24/7)

FONO FAMILIA CARABINEROS **149**

FONOINFANCIA
Apoyo psicológico gratuito para la crianza
800 200 818

Más información en **minsal.cl** o
LLAMA A SALUD RESPONDE
600·360·7777
Profesionales de la salud atendiendo sus dudas las 24 horas, los 7 días de la semana

+56 22 6353800
CITUC
Información Toxicológica